F4 – Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen

ANGST

- gesunde Reaktion auf Bedrohung,
- die Angstsymptome dienen dem Körper dazu sich zu wappnen

Ab wann macht Angst tatsächlich krank?

- Wenn sie ohne reale Bedrohung auftritt
- Wenn sie in einer übertriebenen Angstreaktion mündet
- Wenn sie zu Vermeidungsverhalten führt
- Wenn die Angst auch nach der Bedrohung weiter anhält
- Wenn die Angst den Alltag wesentlich beeinträchtigt (Lebensqualität und Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt)
- Wenn ich mehr als die Hälfte des Tages über meine Ängste nachdenke.
- Wenn ich wegen meiner Ängste werde immer depressiver werde.
- Wenn ich wegen meiner Ängste schon Suizidgedanken habe.
- Wenn ich meine Ängste oft mit Alkohol, Drogen oder Beruhigungstabletten bekämpfe.
- Wenn aufgrund meiner Ängste meine Partnerschaft ernsthaft in Gefahr ist.
- Wenn ich wegen meiner Ängste Probleme im Beruf habe oder deswegen arbeitslos bin.

Epidemiologie

- **Angststörungen - Lebenszeitprävalenz** von ca. 20 Prozent
- Gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen
- **Punktprävalenz** aller Angststörungen gemeinsam wird auf ca. 7% geschätzt.
- häufigste Angststörung = die Phobien

Lebenszeitprävalenz

- der Spezifischen Phobien von ca. 9%
- der Agoraphobie von ca. 5%
- der Generalisierten Angststörung von ca. 5%
- der Panikstörung von ca. 3%
- der Sozialen Phobie von ca. 5%.

F40 Phobische Störungen

- **objektivierbarer Ursache = GERICHTETE Angst**
- die „kranke" Angst wird durch eindeutige, definierte, aber eigentlich ungefährliche Situationen hervorgerufen
- Sie führt zu **Vermeidungsverhalten**
- oder die Situation wird nur mit großer Furcht ertragen

Symptome:

- deutlich erlebte Angst
- **vegetative Symptome der Angst** :

- Herzklopfen und Schwächegefühl, Zittern,Schweißausbruch, Mundtrockenheit
- **Thorax und Abdomen**:
- Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Unruhegefühl im Magen, Schmerzen im Brustraum
- **psychische Symptome**:
- Unsicherheit, Schwäche, Schwindel, Derealisation, Depersonalisation, Angst vor Kontrollverlust, zu sterben
- **allgemeine Symptome:** Hitzewallungen, Kälteschauer
- deutliche emotionale Belastung
- Klassifizierung mit oder ohne Panikattacken möglich

DD:
organische Angststörung, Phobien treten häufig mit depressivem Syndrom auf

F40.0 Agoraphobie:

Symptome:
- mindestens 2 Angstsymptome aus den allgemeinen
- Furcht vor öffentl. Plätzen und Menschenmengen
- Befürchtung, das Haus zu verlassen
- Geschäfte zu betreten
- alleine mit Bus oder Bahn zu reisen
- sich weit von zuhause zu entfernen
- tritt mit oder ohne Panikattacken auf
- wird diagnostiziert mit oder ohne Panikstörung
- Betroffene „helfen" sich, indem sie die Auslöser **vermeiden**

- *Häufigkeit: 5 %*
- *Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer*
- *Beginn zwischen 20. Und 30. Lebensjahr*

Therapie:
Insbes. **Verhaltenstherapie**
- Angstreduktion (Ausweitung des Bewegungsradius)
- Meist Exposition mit Reaktionsverhinderung (massierte Konfrontation in vivo, Graduierte Konfrontation)
- Sorgentagebuch
- Entwicklung von alternativen Lösungsstrategien
- Veränderung der Denkverzerrung
- Rückfallprophylaxe

F40.1 Soziale Phobie

Symptome:
- mindestens 2 Angstsymptome aus den allgemeinen
- zusätzlich: Erröten, Angst zu erbrechen, Angst vor Miktionsdrang
- **Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen**

- deutliche Furcht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen
- deutliche Angst, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
- Tritt mit oder ohne Panikattacken auf
- Betroffene „helfen" sich durch **Vermeidungsverhalten**

DD:
- ängstlich vermeidende PS

- *Häufigkeit: 13 %*
- *Frauen sind eineinhalb Mals so viel betroffen wie Männer*
- *Bei 3/4 der Fälle beginn im Jugendalter*

Therapie:
Insbes. **Verhaltenstherapie**
- Darstellung des Störungsmodells
- Entspannungsverfahren
- Konfrontation - Exposition in vivo in Begleitung des Therapeuten oder alleine
- Ressourcenstärkung
- Training sozialer Kompetenzen
- Kleine Aufgaben im Alltag, z.B. Fremde nach Weg, Uhrzeit fragen
- Kognitive Interventionen: Identifikation und Veränderung dysfunktionaler Gedanken
- Förderung positiver Selbsteinstellung

F40.2 spezifizierte (isolierte) Phobien

Symptome:
- Angstsymptome aus den allgemeinen
- sehr große Angst vor eng umschriebenen Situationen oder Dingen
- Höhen, Tiefen, Enge,
- Tieren
- Gegenständen
- Ärzten, Spritzen etc. etc.
- Deutliche emotionale Belastung, große Krankheitseinsicht
- Betroffene „helfen" sich, indem sie die Auslöser vermeiden
- tritt mit oder ohne Panikattacken auf

DD:
- Hypochondrische Störung
- Wahnhafte Störung

- *Häufigkeit: 10 %*
- *Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer*
- *Beginn meist in der Kindheit*

Therapie:
Insbes. **Verhaltenstherapie**

- Systematische Desensibilisierung
- Exposition und Reaktionsverhinderung in vivo als Methode erster Wahl
- Massierte (flooding) oder Graduierte Darbietung (Angsthierarchie) der angstbesetzten Stimuli
- => Konfrontation eines Patienten mit einer von ihm gefürchteten Stimuli + Reaktionsverhinderung (Unterlassen der Flucht-bzw Vermeidungsreaktion) => Realitätstestung => neue Erfahrung => Korrektur der Katastrophenerwartung
- => kognitiver Aspekt = Veränderung des kognitiven Repräsentationssystems

---

F41 Andere Angststörungen

- **ohne objektivierbare Ursache = UNGERICHTETE Angst**
- Manifestation der Angst ist das Hauptsymptom, ohne dass man genau sagen kann, wann und worauf es sich bezieht

Symptome:
- deutlich erlebte Angst
- **vegetative Symptome der Angst** :
- wie Herzklopfen und Schwächegefühl, Zittern, Schweißausbruch, Mundtrockenheit
- **Thorax und Abdomen**:
- Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Unruhegefühl im Magen, Schmerzen im Brustraum
- **psychische Symptome**:
- Unsicherheit, Schwäche, Schwindel, Derealisation, Depersonalisation, Angst vor Kontrollverlust, zu sterben
- **allgemeine Symptome:** Hitzewallungen, Kälteschauer
- deutliche emotionale Belastung
- Klassifizierung mit oder ohne Panikattacken möglich

DD:
- organische Angststörung,
- Depressionen oder Zwänge können gleichzeitig auftreten

F41.0 Panikstörung

Symptome:
- **wiederholte Panikattacken** ohne spezifische Situation oder Objekt
- **Panikattacke** ist eine einzelne Episode von intensiver Angst, die abrupt beginnt,
- innerhalb weniger Minuten ein Maximum erreicht und bis zu 30 Minuten dauern kann
- in der Situation mindestens 4 Symptome aus allgemein

Formen:
- **mittelgradige**: 4 Panikattacken in 4 Wochen
- **schwere:** 4 Attacken pro Woche in 4 Wochen

- Es entsteht eine Angst vor der Angst.

- *Häufigkeit: 2-3 %*
- *Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer*
- *Beginn zwischen dem 30. Und 50. Lebensjahr*
- *Kann in Kombination mit Agoraphobie auftreten*

Therapie:
Insbes. **Verhaltenstherapie**
- Angstreduktion (Intensität & Frequenz) => Erklärungsmodell vermitteln
- Kognitive Umstrukturierung = Korrektur der Fehlinterpretation, Veränderung der Denkverzerrung
- Verhaltensexperimente (Treppensteigen, Drehstuhl, Koffeinkonsum)
- Alternative Erklärungen auf Verhaltenseben prüfen, Generalisierung
- Meist Exposition mit Reaktionsverhinderung
- Sorgentagebuch
- Entwicklung von alternativen Lösungsstrategien
- Psychodynamische Therapie
- Antidepressiva
- Rückfallprophylaxe

F41.1 Generalisierte Angststörung

Symptome:
- mindestens 6 Monate 4 Symptome aus allgemein
- dauernde Anspannung und Befürchtung in Bezug auf alltägliche Dinge
- nicht auf gewisse Situationen oder Dinge beschränkt, frei flottierend
- Zukunftsbefürchtungen für sich selbst oder Angehörige
- Symptome der Anspannung und Schreckhaftigkeit
- ständige Nervosität, Unfähigkeit zu entspannen, Aufgedreht
- Oberbauchbeschwerden, Einschlafstörungen wg. Sorgen

DD:
- organische Störungen (Bsp. Schilddrüsenüberfunktion)
- psychotrope Substanzen (Amphetamine),
- Depression
- Phobische Störung
- Zwangsstörung

- Häufigkeit: 5%
- Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer
- zwei Häufigkeitsgipfel - in der späten Jugend und um das 40. Lebensjahr

Therapie:
Insbes. **Verhaltenstherapie**
- Kognitive Umstrukturierung (ABC-Modell)

- Veränderung von Sorgen, kognitiven Überzeugungen und dysfunktionalen Kognitionen
- Entspannungsverfahren vermitteln
- Abbau des Vermeidungs- und Rückversicherungsverhaltens
- Aufbau von Bewältigungsstrategien
- Förderung von mit Angst inkompatiblen Aktivitäten
- Stressmanagement
- Sorgenkonfrontation in vivo und in sensu
- Achtsamkeit (Fokus im Hier und Jetzt)
- Gedanken-Stopp
- Antidepressiva, Tranquilizer nur zur Krisenintervention

F41.2 Angst und depressive Störung gemischt

Symptome:

- für beide Störungen liegen Symptome vor, jedoch keine überwiegt
- leichte oder nicht anhaltende ängstliche Depression
- **Fehlen:** - Panikattacken

Ursachen und Auslöser für Angststörungen

- eine Ursache zur Erklärung von Angststörungen gibt es nicht
- unterschiedliche Faktoren wirken wechselseitig aufeinander ein - multifaktoriellen

Biologische Faktoren

- Erbanlagen
- verschiedene angeborene Faktoren herausgearbeitet
- Menschen mit angeborener Ängstlichkeit, d.h. der Neigung, schneller und stärker mit Erregung/ Angst auf ungewisse Situationen zu reagieren als andere (z.B. aufgrund einer Amygdala-Dysfunktion)
- angeborene Verhaltenshemmung, also die Neigung, Neuem mit Vorsicht zu begegnen und sich schneller zurückzuziehen
- -> an sich krankhaft sind, aber eine Vorbelastung (Vulnerabilität)

Psychische Faktoren

Negative Lernerfahrungen:

- Angst irgendwann im Leben erlernt wurde, durch eine direkte negative Erfahrung geschehen, oder durch die Übernahme von Verhaltensweisen und Einstellungen der Eltern
- Oft liegen unangemessene, verzerrte Bewertungen der Situation wie der eigenen Person und deren Möglichkeiten zugrunde.
- Einige typische **Denkfehler**, bei Angstbetroffenen:

- Überschätzung von Gefahren
- Unterschätzung der eigenen Kompetenzen
- Katastrophendenken (das Schlimmste wird passieren)
- Entweder-oder-Denken (entweder bin ich perfekt oder der totale Versager)
- Misserfolg wird auf einen selbst bezogen, Erfolg dagegen auf glückliche Umstände

Innerpsychische Konflikte:

- Angststörung als das Resultat widersprechender Ziele innerhalb einer Person, besonders während der Kindheit
- Zentral = Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit

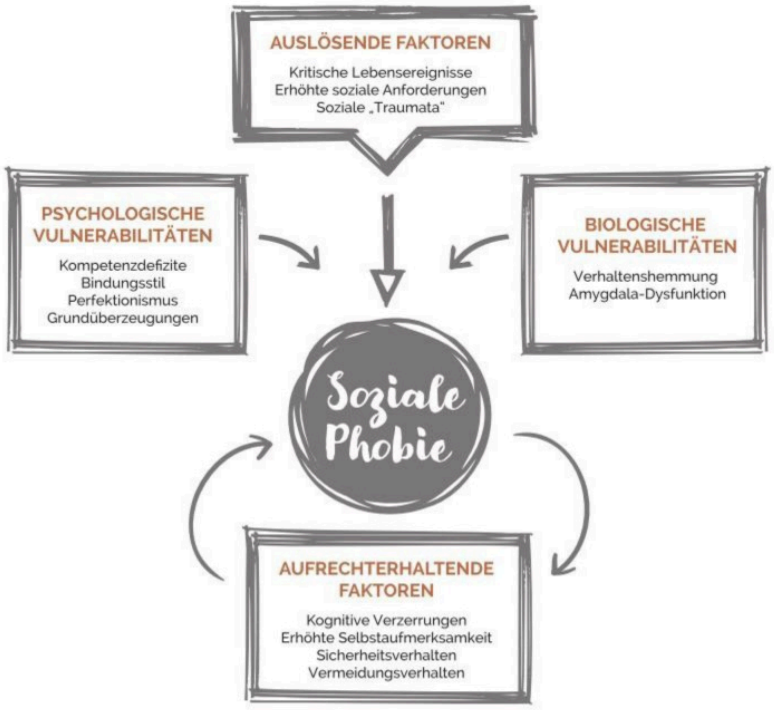
- vernachlässigender bzw. zurückweisender oder als überfürsorglicher, abschirmender Erziehungsstil
- => Kind erwirbt wenig eigene Kompetenzen, Kreativität, Vertrauen in sich selbst entwickeln kaum, Gefühl der Selbstwirksamkeit bleibt auf der Strecke. verzerrte Grundüberzeugungen, wie etwa ein Perfektionismus entstehen
- Traumatische Kindeheits- und Lebenserfahrungen
- Angstlernen am Modell oder über Verstärkung (Angst lohnt sich)

Soziale Faktoren

- Sozioökonomische Verhältnisse: Besitz bzw. Mangel an Geldmitteln
- Soziale Beziehungen: Netzwerk an Freunden und Verwandten vorhanden oder nicht
- Kulturelle Umwelt: Unterschied, ob Angst in einer Gesellschaft stigmatisiert ist oder ob er sich leicht Hilfe holen
- Zu hohe Belastung, Überforderung als Auslöser
- Auslösendes Schlüsselerlebnis, Angst aus realem Erleben
- Unterstützende labialisierende Faktoren: Alkoholisierung, Unterzuckerung (vernachlässigte Ernährung), Einengungen im Gedränge, Streit mit Partner

Krankheit aufrechterhaltend wirkt Gewöhnung an Vorteile der Angst:

- Krankenstand
- Gewährte Hilfsbereitschaft
- Abrufbare Zuwendung von Umgebungsperson
- Hohe emotionale Lebensintensität



Die Ursachen/Vulnerabilitäten einer Angststörung am Beispiel der Sozialen Phobie:

Biologische und psychische (bzw. psycho-soziale) Faktoren führen zusammen mit auslösenden Faktoren zu einer Störung. Aufrechterhaltende Faktoren, insbesondere Vermeidung, stabilisieren die Erkrankung.

•https://www.angstselbsthilfe.de/wissen/ursachen/entstehung-angststoerung/psychologische-biologische-und-soziale-faktoren/ Psychoedukation

- https://www.kkh.de/leistungen/psychische-erkrankungen/angststoerungen

Aus Angstkreislauf leiten sich therapeutische Prinzipien ab:

- Ziel: Teufelskreis an verschiedenen Stellen durchbrechen

KOGNITIVE TECHNIKEN
= infrage stellen automatischer Gedanken, typ. Sind Katastrophisierungsgedanken

FORMEN DER KÖRPERLICHEN ERREGUNGSKONTROLLE
= Atem - und Entspannungsübungen

ABBAU EINER VERSTÄRKTEN SELBSTBEOBACHTUNG
=Richtung der Aufmerksamkeit nach außen
(durch sogenanntes checking-behavior kann es zur Symptomverstärkung kommen)

Konfrontationsverfahren im Überblick

Exposition/ Konfrontation = gezielt mit Reizen auseinandersetzen, konfrontieren

GRADUIERT (schrittweise, systematisch)

- In sensu (in der Vorstellung)
- System. Desensibilisierung (reziproke Hemmung)
- **1. Entspannungstechnik**
- **2. Angsthierarchie**
- **3. abgestufte Exposition** (schwache Angstreize, dann steigern im entspannten Zustand)
- Bei einfachen Phobien

- Reziproke Hemmung: angenehmer Reiz wird an unangenehmen Reiz gekoppelt-> Entspannung an Angst, hemmen sich gegenseitig (PMR = antagonistisches Verfahren zur Angst)

- In vivo (in der Realität)
- Angstbewältigungs- / Habitutationstrainig
- Graduierte Exposition
- **1. Angsthierarchie** (wichtig ist, dass mit der Angst noch kein Vermeidungsverhalten aufgebaut wird, so lange in Angst bleiben, bis Angstkurve nachlässt, damit sie habituiert)
- Hier KEIN antagonistisches Verfahren
- 2. **leichte bis mittlere angstauslösende Reize**
- Bei Agoraphobie, soz. Phobie, Zwang, PTBS

MASSIV (plötzlich, intensiv)

- Flooding in sensu (Implusionstherapie)
- Massive Vorstellung der stärksten angstauslösenden Situation
- -> Gefühle, Gedanken höchster Intensität
- -> Angst, so stark, dass sie implodiert, in sich zusammenbricht
- Keine kognitive Vermeidung, sonst keine Habituation
- Bei PTBS, Zwang

- **Flooding in vivo**
- Stärkste angstauslösende Reize

- internistische Abklärung ist wichtig
- Keine motorische oder kognitive Vermeidung
- Agoraphobie mit Panikstörung, schwere Phobie, soziale Phobie, Zwang

KONTRAINDIKATIONEN für Expositionsverfahren

- Psychotische Episoden in der Vorgeschichte
- Bluthochdruck
- Nach Herzinfarkt
- Zu geringe körperliche Belastbarkeit
- Organische Ursache der Angstsymptome
- Substanzabhägigkeit
- Angstauslösende Medikamente
- Habituationsblockade
- Minderbgabung
- Hirnorganische Störungen
- Wenig vertrauensvolle oder konfliktreiche Therapeuten-Klienten-Beziehung

SELBSTHILFE

Gedanken-Stopp

Jedes Mal, wenn die Gedanken überhandnehmen, sagen Sie laut oder in Gedanken „stopp!", um die Gedanken zu unterbrechen. Um den Befehl zu verstärken, können Sie gleichzeitig in die Hände klatschen, aufspringen, auf den Boden stampfen oder eine andere Handlung durchführen.

Atemtechnik:

Länger ausatmen

1. Atmen Sie ein und zählen Sie langsam von eins bis vier
2. Halten Sie für einen Moment die Luft an
3. Atmen Sie durch den leicht geöffneten Mund aus und zählen Sie langsam von eins bis sechs.

Widerholen Sie diese Schritte so lange, bis sich Ihre Gedanken beruhigt haben.
So können Sie Ihr Gedankenmuster durchbrechen. Durch die Konzentration auf die Atmung und das Zählen gönnen Sie Ihrem Geist eine Auszeit.

Positive Affirmationen

- Formulieren Sie Sätze, die persönliche Stärken und Fähigkeiten beinhalten. Sie helfen dabei, die negativen Glaubenssätze zu entkräftigen.
- Eine Affirmation sollte:
    - kurz sein,
    - realistisch sein,
    - in der Gegenwart sein (z. B . „Ich bin mutig."),
    - positiv formuliert sein (z. B. „Ich bin stark und stabil." oder „Ich gehe meinen Weg voller Kraft, Mut und Vertrauen.")
- Sagen Sie diese Affirmation mehrmals täglich laut.

Sorgenplatz

- Widmen Sie jeden Tag zur einer festen Zeit 20 Minuten nur Ihren Gedanken, Sorgen und Grübeleien.
- Wählen Sie dafür einen neutralen Ort, der nicht Ihr Lieblingsort ist.
- Setzen Sie sich entspannt hin und lassen Sie all Ihre Gedanken und Sorgen kommen und gehen. Versuchen Sie, die Gedanken nicht zu bewerten.
- Wenn tagsüber Sorgen und Gedanken kommen, schieben Sie sie bewusst weg. Kümmern Sie sich erst zu Ihrer festgelegten Zeit an Ihrem festen Sorgenplatz darum.

Entspannung/Achtsamkeit

Um Stress abzubauen und gelassenere Haltung zu entwickeln
z.B. Progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

Schriftliches Festhalten

- **Angstprotokoll**:
  Es hilft Ihnen nicht nur bei Angst, sondern schärft Ihr Bewusstsein praktisch für jede Art von negativen Gedanken und Gefühlen.
- **Bewertungsprotokoll**:
  Sie dokumentieren damit, wie Sie bestimmte Situationen für sich einordnen.
- **Angst-Entspannungsprotokoll**:
  Halten Sie fest, mit welchen Entspannungsmethoden Sie auf welche Ängste reagieren können.

F42 Zwangsstörungen

- = quälende, als unsinnig erlebte Gedanken, Handlungen oder Impulse, die sich aufdrängen und nicht unterlassen werden können, obwohl der Betreffende darunter
- leidet.
- **Werden sie nicht ausgeführt, erlebt der Betroffene Angst.**
- Manifestiert sich meist in den frühen Lebensjahren (Kind bis junger Erwachsener)

Symptome:

- Zwangsgedanken oder Handlungen an den meisten Tagen in 2 Wochen
folgenden Merkmale:
- sie werden als eigene Gedanken angesehen,
- sie wiederholen sich dauernd und werden als unangenehm empfunden
- die Betroffenen versuchen, Widerstand zu leisten
- die Ausführung eines Zwangsgedankens oder einer Zwangshandlung ist für sich genommen nicht angenehm, lediglich wird eine vorüber- gehende Erleichterung empfunden
- Beeinträchtigung der sozialen Leistungsfähigkeit (Zeitaufwand)

- Zwänge treten begleitend auf bei Schizophrenien, Affektiven Störungen und müssen abgegrenzt werden.

DD:

- zwanghafte PS

- Werden zu Neurosen gezählt
- Werden als quälend und unsinnig erlebt -> **ich-dyston**

ZWANGSGEDANKEN
-drehen sich häufig um Gesundheitsgedanken und sexuelle Phantasien

ZWANGSIMPULSE
- I.d.R. Impulse, moralisch und gesellschaftlich unerwünschte Dinge zu tun
- (jemanden töten, verletzen, peinliche Dinge tun)
- Impulse können gut unterdrückt werden, das geht jedoch mit Gefühl
- erhöhter Anspannung einher

IMPULSHANDLUNG
- Handlung aus einem Zwangsimpuls heraus

ZWANGSHANDLUNGEN
- Handlungen, die aus den jeweiligen Themen/ Formen des Zwangs abgeleitet werden

ZWANGSRITUALE
- Dabei kommt es zu „Schutzhandlungen" -> die Betroffenen haben das Gefühl es würde ein schlimmes Unglück geschehen, wenn sie diese Handlung nicht ausführen können
- Gleichzeitig wissen sie um die Unsinnigkeit dieser Verknüpfung
- = magisches >Denken (Kontrollillusion)

Formen, Themen des Zwangs

1. REINLICHKEITSZWANG
- Häufigster Zwang
- Eher bei Frauen
- Große Angst vor Verunreinigung => entweder selbst angesteckt zu werden (häufiger) oder andere zu gefährden und mit lebensgefährlichen Erregern zu identifizieren (seltener)

2. KONTROLLZWANG
- Am zweithäufigsten
- Menschen kontrollieren Alltagsdinge, da ein Versäumnis eine Ursache für eine Katastrophe sein könnte
- Gibt es in Kombination mit Zählzwang

3. ZÄHLZWANG
- Bestimmte Dinge müssen immer wieder gezählt werden

4. ORDNUNGSZWANG
- Betroffene haben ein eigenes sehr strenges, sehr penibles Ordnungssystem, was immer weiter verfeinert wird
- Ordnungszänge und Wiederholzwänge verbrauchen extrem viel Lebenszeit

5. BERÜHRZWANG

- Betroffene verspüren den Zwang bestimmte Dinge anzufassen oder keinesfalls anzufassen

6. WIEDERHOLZWANG
- Ist mit Zählzwang gekoppelt
- Best. Tätigkeit müssen in einer bestimmten zahlenmäßigen Häufigkeit wiederholt werden

7. SAMMELZWANG
- Betroffene können nichts wegwerfen, aus Angst es könnte etwas Wichtiges gewesen sein

F42.0 vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang

Symptome:
- Symptome mindestens 2 Wochen
- zwanghafte Ideen
- bildhafte Vorstellungen
- Zwangsimpulse (ohne nachfolgende Handlung)

F42.1 vorwiegend Zwangshandlungen (Zwangsrituale)

Symptome:
- Symptome mindestens 2 Wochen
- Stereotypien, meist auf Tätigkeiten mit Ritualen bezogen
- Ordnungszwang, Putzzwang, Kontrollzwang, Sammelzwang, Wiederholungszwang

F42.2 Zwangsgedanken – und handlungen gemischt

Symptome:
- Symptome mindestens 2 Wochen
- siehe oben

Komorbide Erkrankungen:
- Schizophrene Psychosen
- Agsterkrankungen
- Affektive Störungen
- Anorexie
- Suchterkrankungen

Entstehung und Aufrechterhaltung

- viele verschiedene Faktoren - multifaktoriell
- **genetische Faktoren**
- gestörte Balance von **Hirnbotenstoffen**,
- vor allem auch **ungünstige Lernerfahrungen** (meist schon im Kindes- und Jugendalter)
- bestimmte Persönlichkeitsmerkmale

- Aufrechterhalten wird eine Zwangsstörung über einen sich selbst verstärkenden **Teufelskreis**.
- Das Herausarbeiten von individuellen Faktoren der Betroffenen ist ein wichtiger Schritt in der Psychotherapie.

Biologische Faktoren:

- **genetische Veranlagung**
- für Angehörige von Menschen, die an einer Zwangsstörung leiden, besteht ein 3- bis 12-fach erhöhtes Risiko besteht, ebenfalls an einer Zwangsstörung zu erkranken.
- Womöglich ist dieser genetische Einfluss bei Zwangsgedanken und bei einem frühen Beginn der Störung besonders hoch. Heute wird davon ausgegangen, dass Zwänge mit einer **Überaktivität in bestimmten Hirnregelkreisen** einhergehen => automatische Handlungsimpulse können schlechter gehemmt werden können
- bestimmte **Botenstoffe im Gehirn** (sogenannte "Neurotransmitter", v.a. Serotonin, aber auch Noradrenalin) scheinen nicht ausreichend vorzuliegen

Psychologische Faktoren:

- **Lernerfahrungen**, **Lebensereignisse** und **Persönlichkeitsfaktoren**
- Häufige Kindheitserfahrungen: seitens des Elternhauses hohe Leistungserwartungen, Strenge, hohe moralische Standards, ein eher überbeschützender Erziehungsstil
- überdauernde Persönlichkeitsfaktoren z.B. Perfektionismus, verinnerlichte hohe Standards, erlebte hohe Verantwortlichkeit, Ängstlichkeit und hohe Angepasstheit an Normen und Wertvorstellungen
- Prägende biographische Ereignisse

Wie werden Zwangsstörungen aufrechterhalten?

- ein Grund ist möglicherweise, dass die Faktoren, die zur Entstehung des Zwanges geführt haben, weiterhin bestehen
- Zwänge sind oft stärker, wenn man innerlich unter Anspannung steht, unter Zeitdruck ist, wenig geschlafen hat etc => Protokollierung der Zwänge dazu um ungünstige Lebensgewohnheiten zu identifizieren
- **"positive" Nebeneffekte** für die Betroffenen = "**Funktionalität**" des Zwanges

- ein sich selbst verstärkender **Teufelskreis der Zwangsstörung**

Hier ist der **Teufelskreis der Zwangsgedanken** noch einmal bildlich dargestellt:

Typische Funktionalitäten von Zwang

- Schutz vor dem Erleben eines aversiven Gefühlszustandes (z.B. Angst / Unruhe, Wut, Trauer, Versagenserleben)
- Produkt und Kompensation von Bindungsunsicherheit und Machtlosigkeit (hohes Maß an Unberechenbarkeit / Unsicherheit in der Ursprungsfamilie)
- Mittel zur Abgrenzung gegenüber anderen z.B. Jugendliche, die ihre autoritären Eltern durch Kontroll- und Ordnungszwänge auf Distanz halten
- Ventil für unterdrückten Groll („Ich will noch Aufmerksamkeit von dir.Die biografisch-systemische Analyse gemeinsam mit einem*r Therapeut*in wird hier die relevanten "positiven Funktionen" des Zwanges herausstellen. Anhand dieser Analyse wird hier schon deutlich, dass es sich bei der Behandlung des Zwanges nicht um eine reine Behandlung des Symptoms handeln kann, sondern dass auch diese "Faktoren im Hintergrund" in der Behandlung berücksichtigt werden müssen.

Therapie bei Zwangserkrankungen:

- zwei wichtigen Bausteinen - **Psychotherapie** (z.B. Kognitiv-behaviorale) und Psychopharmakotherapie

Zusammengefasst:

Psychotherapie bei Zwängen

Psychoedukation

- zunächst “Psychoedukation” = erklären den Betroffenen (und Angehörigen), was ein “Zwang” ist, die Ursachen und wie Zwänge behandelt werden

1. Beziehungsgestaltung und Motivationsaufbau

- Exposition NIE vor Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung

2. Therapietechnik und Inhalte

- Veränderung der problemsicht(Angst vor etwas)
- Reduktion der subjektiven Bedeutung aufdringlicher Gedanken (Gedanke ist nur Gedanke, ohne Handlungsrelevanz)
- Exposition mit Reaktionsverhinderung
- Kognitive Umstrukturierung in Bezug auf die Überschätzung der Gefahr (Wahrscheinlichkeit negativer Ereignisse wird von Patienten überschätzt)
- Kognitive Umstrukturierung in Bezug auf die Überschätzung der persönlichen Verantwortung (sich Schuld geben)
- Einsatz von Verhaltensexperimenten (z.B. Risikoübungen)
- Entspannungsverfahren

- bei Zwangserkrankungen besonders wichtig, da Zwänge häufig sehr **schambesetzt,** Betroffenen versuchen oftmals aus Scham, ihre Zwänge zu verbergen
- Wenn die Zwänge sehr ausgeprägt sind kommt es häufig vor, dass die Betroffenen ihre Angehörigen mit in ihre Zwänge einbinden
- darum sollten Angehörigen ebenfalls über die Zwänge aufgeklärt werden

Funktionsanalyse

- erarbeiten, mit den Betroffenen zusammen, welche **Bedürfnisse** durch den Zwang (unbewusst) erfüllt werden, wie z.B. der Wunsch nach Sicherheit oder nach Unversehrtheit der Familie.

Zwangshierarchie

- erarbeiten einer so genannte "Zwangshierarchie", in der die Zwänge und ihre Auslöser nach ihrem "Schweregrad" eingeteilt werden
- wichtige Grundlage für die Durchführung der **Zwangsexpositionen**

Zwangsprotokolle

- wichtiges Therapieelement
- Betroffenen dokumentieren die bei ihnen auftretenden Zwänge und die mit diesen verbundenen Befürchtungen und Konsequenzen
- diese werden im Anschluss mit Therapeuten / Therapeutin analysiert und alternative, hilfreichere Denk- und Verhaltensweisen entwickelt

Alternativverhalten

- erarbeiten eines hilfreicheren **Alternativverhaltens** zum Zwang
- wichtig, da die Zwänge im Hintergrund zumeist ein eigentlich sinnvolles Ziel haben

Entkatastrophisierung und Realiätskontrolle

- erarbeiten - wie wahrscheinlich die von ihnen befürchteten Konsequenzen wirklich eintreten.

Expositionstherapie

- In der Zwangsbehandlung hat sich dazu die sogenannte Technik der **graduierten Exposition mit Reaktionsmanagement** etabliert.

- **Ziel** = die aufkommenden Gefühle (wie z.B. Angst und Hilflosigkeit), Gedanken (z.B. Sorgen und Schuldvorwürfe) und Körperreaktionen (z.B. Anspannung, Schwindel) auch ohne die Durchführung der Zwänge (über-)leben können

1. eigenen, persönlichen **Trainingsplan aufstellen -** genauen Übungsablauf überlegen, dabei Trainingsschritt in verschiedene Trainingseinheiten aufteilen
2. **Zwangshierarchie** aufstellen (Zwänge entsprechend ihres Schweregrades auflisten)
3. überlegen, was eigentlich exponiert werden soll - **Exponiert werden muss nicht die scheinbare "sachliche" Seite der Zwänge - also z.B. der Herd oder die Haustür - sondern die bedrohlichen Gefühle und Gedanken, die mit diesen verbunden sind.**
4. **Exposition**

- zunächst anhand der **Zwangshierarchie** für die erste Exposition eine **Situation im mittleren Anspannungsbereich** bei einer Intensität von ca. 40 bis 50% auswählen (= „**graduierte"** Exposition)
- vor Exposition Grundanspannung des Betroffenen auf einer Skala von 0 bis 100 erfragen
- Betroffenen versuchen dann, das im Vorfeld erarbeitete neue, zwangsfreie Verhalten in dieser Situation umzusetzen und keine Zwänge oder Rituale einzusetzen (=Reaktinsverhinderung)
- Wichtig ist, dass die Betroffenen in der Exposition ihre Anspannung direkt erleben und nicht nur "aushalten",
- => nur so können sie wieder erlernen, dass sie selbst die Kontrolle über ihre emotionalen, gedanklichen und körperlichen Reaktionen haben ("Reaktionsmanagement").
- Nach Überschreitung des Spannungshöhepunktes klingt die Anspannung häufig von selbst ab.
- Expositionen sollten so oft wiederholt werden, bis alle Zwänge ausreichend überwunden sind

  Falls die Anspannung auch während einer längeren Exposition nicht von alleine absinkt, kann es sein, dass die Betroffenen Vermeidung einsetzen,
- meistens **nicht aus Absicht**, oft sogar, ohne es zunächst selbst zu bemerken.

<u>Mögliche Vermeidungsstrategien sind</u>:

- **Gedankliche (kognitive) Vermeidung:** Zum Beispiel "Der Therapeut ist ja dabei...", "Es ist ja gar nicht so schlimm...", "Mir wird schon nichts passieren...", "Ich habe ja meine Notfall-Tropfen dabei...".
- **Inhaltliche Vermeidung:** Zum Beispiel Türklinke nur mit dem Taschentuch oder nur mit einigen Fingern statt mit der ganzen Hand anfassen.
- **Absichtliche oder unabsichtliche Täuschung der Therapeuten:** Zum Beispiel durch Verschweigen der schwerwiegendsten oder "peinlichsten" Zwänge.
- **Vermeidung durch Alkohol, Medikamente o.ä.:** Zum Beispiel vor der Exposition Beruhigungsmittel oder "Notfall-Tropfen" nehmen.

- **Emotionale Vermeidung:** Zum Beispiel unangenehme Gefühle nur "aushalten" statt sie zu erleben.
- **Zeitliche oder inhaltliche Verschiebung:** Zum Beispiel die Zwangshandlung später nachholen oder die Anspannung durch andere Zwänge abbauen.
- **Vermeidung durch Abgabe der Verantwortung:** "Wenn doch etwas passiert, ist der Therapeut ja dabei...", "Der Therapeut wird den Herd schon nicht anlassen...".
- **Vermeidung durch Verweigerung oder Abbruch:** Zum Beispiel den Termin für die Exposition "vergessen".

kurzfristiges Ziel der Exposition = Reduktion der Anspannung um mindestens 30 Intensitätspunkte
Langfristige Ziele = u.a. das Erlernen des gesunden, zwangsfreien Verhaltens und damit der Abbau der Zwänge und der Wiedergewinn der Lebensqualität.

Psychopharmakotherapie

- Psychotherapie zumeist als Mittel der ersten Wahl
- ergänzende Behandlung mit einem Medikament ist sinnvoll
  - wenn die Betroffenen unter sehr **ausgeprägten Zwängen** leiden, die durch die Psychotherapie alleine aktuell nicht ausreichend zu behandeln sind,
  - wenn neben den Zwängen auch ausgeprägte **Depressionen** bestehen oder
  - wenn vorrangig ausgeprägte **Zwangsgedanken** bestehen.

- häufig werden **Serotonin-Wiederaufnahmehemmer**, insbesondere **SSRI** eingesetzt (u.a. die SSRI Fluoxetin, Fluvoxamin, Escitalopram und Paroxetin)
- die Dosierung dieser Medikamente liegt bei schweren Zwängen häufig höher liegen muss als in der Depressionsbehandlung
- Wirkung tritt erst nach ca. 4-12 Wochen ein (Betroffenen informieren, um vorzeitige Therapieabbrüche wegen angenommener "Wirkungslosigkeit" zu verhindern)
- Neben Behandlung mit Medikamenten ist regelmäßige psychotherapeutische Behandlung wichtig, denn bei reiner Medikamententherapie besteht – auch bei zunächst gutem Erfolg – eine Rückfallrate von über 80%

Was können Angehörige bei Zwängen tun?

Schwere Zwangserkrankungen haben häufig auch einen großen Einfluss auf die **gesamte Familie** der Betroffenen. Da die Erkrankten durch die Zwänge zum Teil sehr in ihrem Leben eingeschränkt sind, können bei schweren Zwangserkrankungen selbst Alltagstätigkeiten zu einem Problem werden.

Oftmals wenden sich sogar zuerst die **Angehörigen** mit einem "Hilferufe" an ihren Hausarzt - noch bevor der Erkrankte selber den Schritt in die Behandlung findet.

Die Angehörigen stehen dann oftmals vor großen Schwierigkeiten: Wie sollen sie sich verhalten? Sollen sie dem Erkrankten die für ihn schwierigen Aufgaben abnehmen oder verstärken sie dadurch die Zwänge? Sollen sie ihm gut zu reden oder sollten sie ihm mehr Druck machen?

Füllen Sie ihre eigenen Reserven wieder auf

Das Leben mit einem Zwangserkrankten kann für die Angehörigen zum Teil eine **massive Belastung** sein, das wissen sie vermutlich selbst aus ihrer eigenen Erfahrung. Zwänge entwickeln sich über viele Jahre, und auch die Therapie dauert meist mehrere Jahre, bis wirklich alle Zwänge "verschwunden" sind. Sie als Angehöriger können dabei eine ganz wichtige Unterstützung für die Betroffenen sein. Aber dafür brauchen Sie viel Kraft und Energie.

Es ist deswegen sehr wichtig, dass Sie zunächst einmal für sich selbst ausreichend **Ausgleich von der Krankheit** finden, um Ihre eigenen Energiereserven wieder aufzufüllen. Erst dann können Sie es schaffen, dem Erkrankten auch langfristig zu helfen, ohne selbst dabei krank zu werden.

Wie dieser Ausgleich aussehen kann, ist für jeden Menschen unterschiedlich. Überlegen Sie vielleicht einmal, was Ihnen gut getan hat, bevor die Zwänge ihres Angehörigen so stark wurden. Vielleicht gibt es da etwas, das Sie gerne wieder reaktivieren möchten. Besprechen Sie dies ruhig **offen** mit dem Erkrankten, er hat vermutlich schon selbst bemerkt, wie sehr Sie durch die Zwänge mitbelastet sind.

Bestärken sie den Betroffenen, eine Therapie zu beginnen

Für viele Zwangspatienten sind die Zwänge mit einem sehr großen **Schamgefühl** verbunden. Es kann für die Erkrankten deswegen sehr schwierig sein, mit ihrem Hausarzt über die Zwänge zu reden oder einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Versuchen sie deswegen so gut es geht den Betroffenen darin zu **bestärken**, dass er eine **Therapie**beginnt.

Eine Zwangserkrankung, die länger als ein Jahr besteht, hat bei Erwachsenen nahezu keine Chance mehr auf eine Spontanheilung - eine Therapie ist also unumgänglich. Trotzdem muss die Entscheidung "für" eine Therapie letztendlich von den Betroffenen selber kommen. Sie können aber zum Beispiel anbieten, mit dem Erkrankten gemeinsam zu ihrem Hausarzt zu gehen, um ihn dort zu **unterstützen** und für ihn **da zu sein**, wenn er Hilfe braucht.

Versuchen Sie, die Zwänge nicht persönlich zu nehmen

Viele Angehörige kennen das: Sie dürfen zum Beispiel das Auto des Erkrankten nicht benutzen, dürfen nicht im gleichen Bett schlafen, dürfen seine Sachen nicht anfassen. Auch wenn es manchmal schwer fällt: Zwänge sind eine Krankheit und die Erkrankten verhalten sich so, weil ihnen **die Krankheit gar keine andere Möglichkeit lässt** - und nicht etwa, weil sie plötzlich etwas gegen ihre Angehörigen haben.

Bitte keine Appelle an das Durchhaltevermögen und den gesunden Menschenverstand

Es passiert wohl jedem Angehörigen früher oder später: Der **Appell** an den Erkrankten, sich doch endlich mehr anzustrengen. Und die **Diskussion**, dass die Zwänge unlogisch sind und dass doch auch der gesunde Menschenverstand einem klar macht, dass die Zwangsrituale gar nicht notwendig sind.

Dass diese Diskussion entsteht, ist menschlich - aber Sie können davon ausgehen: Die Erkrankten **wissen**, dass ihre Zwänge übertrieben und wenig zielführend sind. Und trotzdem **können** sie nicht alleine aus diesen Zwängen ausbrechen. Die Diskussion über die Zwänge löst bei den Erkrankten dann eher Schuldgefühle und Frustration aus, da sie ja schon "alles versucht" haben, was ihnen selber möglich war.

Machen sie die Zwangsrituale nicht mit

Die Zwangserkrankung führt häufig dazu, dass die Erkrankten im Verlauf ihre Angehörigen (zumeist **unbewusst**) mit in ihr Zwangssystem einbauen. Dies können kleine Dinge sein, wie die Bitte, nochmals die Türen und Fenster zu kontrollieren, bis hin zu komplexeren Zwangssystemen. Treffen Sie mit dem Erkrankten eine klare Absprache! Es ist nicht hilfreich, wenn sie die Zwangsrituale mitmachen.

Passen Sie ihr Leben nicht an die Zwänge an

Das Ziel der Zwangstherapie ist ja gerade, dass die Erkrankten lernen, wie sie wieder selber die Kontrolle über ihr Leben bekommen, und wie sie dem Zwang diese Kontrolle entreißen können. Deswegen versuchen

Sie bitte - auch wenn es zu Anfang schwer fällt - sich auch selbst an diese wichtige Grundregel zu halten:
Nicht der Zwang darf das Leben beherrschen, sondern das Leben den Zwang!
Versuchen Sie, mit den Betroffenen zu besprechen, welche gemeinsamen Aktivitäten vielleicht trotz der Zwänge noch möglich sind, und versuchen Sie, diese wieder in kleinen Schritten immer mehr auszuweiten.

Sparen sie nicht an Lob
Viele Zwangspatienten bemühen sich extrem, eine Verbesserung ihrer Zwänge zu erreichen - und die Angehörigen bekommen davon gar nichts mit. Wenn es um Zwangserkrankungen geht, müssen Sie leider in neuen Dimensionen denken: Für die Betroffenen kann es schon eine **immense Anstrengung** sein, zum Beispiel das Händewaschen von 30 auf 20 Minuten zu reduzieren oder eine Tür nicht zu kontrollieren. Bestärken Sie diese Erfolge, wann immer es geht. Auch wenn sie aus der Sicht eines "Gesunden" manchmal noch so klein aussehen, sind sie für die Erkrankten oftmals **riesige Schritte**, die bei ihnen große Anspannung und Unwohlsein auslösen können.

Seien Sie nicht zu enttäuscht über Rückfälle
Der **Heilungsverlauf** ist bei einer Zwangserkrankung häufig durch ein **auf und ab** von Erfolgen und Misserfolgen gekennzeichnet. Seien Sie bitte nicht zu enttäuscht, wenn es mal wieder zu einem Misserfolg kommt. Es geht den Zwangserkrankten so, wie kleinen Babys, die Laufen lernen: Das Stolpern und Hinfallen gehört dazu. Wichtig ist, dass sie die Erkrankten **ermutigen wieder aufzustehen** und trotz aller Probleme **weiter zu üben**.

Niemand ist Schuld an den Zwängen
Zwangsstörungen sind in eine Krankheit, von der in Deutschland ungefähr 2 Prozent der Bevölkerung im Lauf ihres Lebens betroffen sind. **Zwangserkrankungen schleichen sich ein.** Sie beginnen meist schon in der Jugend, nehmen dann langsam zu, bis es irgendwann zu immer ausgeprägteren Zwängen kommt. An der Entstehung der Krankheit ist niemand Schuld - nicht die Betroffenen und nicht die Angehörigen.

Erlauben Sie sich, auch mal wütend zu sein
Erlauben Sie sich, auch mal **wütend** zu sein - aber bitte **auf den Zwang**und nicht auf den Erkrankten. Dass sie wütend oder ärgerlich werden, ist vollkommen menschlich und natürlich. Doch stellen Sie sich bitte vor, der Erkrankte hätte eine andere chronische Erkrankung, zum Beispiel eine schwere Krebserkrankung: Sie wären vermutlich aufgewühlt, traurig, wütend, frustriert usw. - jedoch nicht auf den Erkrankten sondern auf die Krankheit. Versuchen Sie deswegen bitte so gut es geht, ihre Wut auf den Zwang und nicht auf den Erkrankten zu richten.

Gehen Sie mit zu den Therapiegesprächen
Zwangserkrankungen **überfordern** häufig die Familie beziehungsweise die Partnerschaft. Bitten Sie deswegen den Betroffenen, dass sie regelmäßig, ca. einmal im Monat, mit zu den Therapiesitzungen gehen dürfen, damit sie dort **gemeinsam** mit dem Betroffenem und der Psychotherapeutin / dem Psychotherapeuten erarbeiten können, wie Sie sich verhalten können, was Sie vielleicht schon alles richtig machen, und wo vielleicht noch Veränderungen hilfreich wären.

https://xn--zwnge-hra.info/zwangsgedanken

F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen

„Nervenzusammenbruch"

Die Diagnosen unter F 43 beschreiben einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen einer aussergewöhnlichen schweren Belastung und der unmittelbaren Reaktion des Menschen darauf, der diesen Belastungen ausgesetzt ist.

Direkte Folge eines kontinuierlichen Traumas oder einer akuten schweren Belastung
= primärer und ausschlaggebender Kausalfaktor

Beispiele Belastungssituationen

- Unfälle
- Todesfälle
- Finanzielle und berufliche Verluste
- Bedrohliche Erkrankungen
- Naturkatastrophen
- Kriegsereignisse
- Vergewaltigung
- Körperverletzung

Symptome:

die Störungen entstehen immer als direkte Folge des Ereignisses
die Störung wäre ohne diese belastenden Ereignisse nicht entstanden

DD:

Störungen, die ähnliche Symptome hervorrufen, Bsp. Psychotrope Substanzen oder organisch verursachte Störungen

Klassifikation in drei Gruppen:

F 43.8 Akute Belastungsreaktion

- direkt nach dem Ereignis auftretend und kurz andauernd
- Beginn einige Minuten nach Ereignis, Abklingen nach einigen Stunden bis drei Tagen
- Symptomatisch sind Schock, Betäubung, Angst, Fluchtgefühle aber auch vegetative Symptome wie Herjagen und Schweißausbrüche

F 43.1 Posttraumatische Belastungsstörung

- verzögerte oder protrahierte, über langen Zeitraum anhaltende Reaktion
- Beginn innerhalb eines Monats nach dem Ereignis, Abklingen meist nach sechs Monaten
- Bei Chronifizierung die länger als zwei Jahre anhält, Übergang zu einer Persönlichkeitsveränderung möglich (=> Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung, ICD 11 Komplexe PTBS)
- Schwerste Belastung und Bedrohung von katastrophalem Ausmaß

- Häufig nach einer anfänglich akuten Belastungsreaktion
- Typische Merkmale wie das wiederholte Nacherleben des Traumas oder Vermeidungsverhalten

F 43.2 Anpassungsstörungen

- Beginn innerhalb eines Monats nach dem Ereignis, Abklingen meist nach sechs Monaten, ausser längere depr. Reaktionen, die 2 Jahre anhalten können
- Betroffene sind nicht in der Lage, sich einer belastenden Lebenssituation, die mit einschneidenden Veränderungen einhergeht, anzupassen
- Psychosoziale Belastungsfaktoren
- Länger andauernde psychische Symptome

- *Die Übergänge zw. Normaler Reaktion und Reaktion mit Krankheitswert sind fließend*
- *Akute Belastungsreaktionen oder akute traumatische Stressreaktion ist zunächst eine natürliche und normale Reaktion auf abnorme Ereignisse, bei denen die Integrität des Menschen bedroht war -> Keine behandlungsbedürftige PTBS, nimmt mit der Zeit ab*
- *Leiden unter Verlust eines Zugehörigen ist zunächst keine Anpassungsstörung, sondern eine normale Trauerreaktion*
- *Ausschliessen Organ. Ursachen und andere Psych. Störungen*
- *Häufig Grenzfälle => gesamtes Spektrum der Psych. Störungen überprüfen*
- *Oft unklar, ob ausser dem belastenden Ereignis andere Faktoren hinzukommen, die die Reaktion aufrecht erhalten*
- *Belastende Ereignisse und psychosoz. Belastungen können Auslöser für andere Psych. Störungen sein*
- *Angst oder affektive Symptomatik sind dann nicht Ausdruck einer Belastungsreaktion, sonder Angststörunge oder depressive Episode*

Ätiologie

Biolog. Vulnerabilität

- genetische oder biochemische Anfälligkeit oder Sensibilität
- Geburtstrauma
- Vererbte oder früh erworbene konstitutionelle Verletzbarkeitführt zu einer Disposition von Belastungsstörungen
- => eingeschränkte Regulationsfähigkeit

Auffällige Persönlichkeitszüge und neurotische Verhaltensweisen

- Ängstlich asthenische Persönlichkeit
- Emotional instabile Persönlichkeit
- Individuell bevorzugte COPING-STRATEGIE

Mangel an Ressourcen

v.a. soziales Netzwerk mit zuverlässiger sozialer Unterstützung
=> sofortige Hilfe und emotionale Absicherung können Belastungsfolgen deutlich mindern

43.2 Anpassungsstörung

Symptome:

- Beginn innerhalb 1 Monates nach einem subjektiv bedrängend erlebtem Geschehen, nicht außergewöhnlich oder katastrophenartig,
- Dauer nicht länger als 6 Monate (außer depressive Reaktion)
- **identifizierbare psychosoziale Belastung**
- Symptome wie bei affektiven Störungen aber nicht so stark
- Kein Symptom stark genug für eine andere Diagnose

Formen:
- mit kurzer oder längerer depressiver Reaktion (1 Monat, 2 Jahre) - mit Angst und depressiver Reaktion gemischt
- mit vorwiegender Störung von anderen Gefühlen (für Kinder)
- mit überwiegender Störung des Sozialverhaltens (Jugendliche)

Das Ereignis kann das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben, sein berufliches Umfeld, ein Umbruch der Lebensumstände, Todesfall, Organverlust!!!, schwere Krankheit eines Angehörigen

43.0 akute Belastungsreaktion

Symptome:
- Beginn innerhalb 1 Stunde nach der Belastung, die innerhalb von Stunden (8 bis 48) nachlassen und zurückgehen.

Symptomgruppe 1: (sind aus Angststörungen)
a) vegetative Symptome der Angst b) Abdomen und Thorax
c) Psychische Symptome
d) Allgemeine Symptome

Symptomgruppe 2
A. Rückzug von erwarteten sozialen Interaktionen
B. Einengung der Aufmerksamkeit
C. Offensichtliche Desorientierung
D. Art von „Betäubung" = „gewisse Bewusstseinseinengung"
E. Ärger oder verbale Aggression
F. Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit
G. Unangemessene oder sinnlose Überaktivität
H. Unkontrollierbare und außergewöhnliche Trauer

Möglicher **Ablauf in 3 Phasen** entnommen dem „K.Lieb"
1. Betäubung, Gefühl innerer Leere, verminderte Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit, zusätzlich evtl. körperliche Symptome der Angst (Schwitzen, Herzklopfen, Zittern, etc.)
2. Desinteresse, Sozialer Rückzug, gelegentlich dissoziativer Stupor, Antriebsminderung oder das Gegenteil: Unproduktive motorische Hyperaktivität, Unruhe, Weglauftendenzen (Fugue), Gefühle von Verzweiflung, Angst, Panik oder Ärger
3. In Folge dann: deprimierte Stimmung, Hoffnungslosigkeit, Neigung zum Weinen, Ängstlichkeit, Grübeln, Gedankenkreisen, Schlafstörungen, Appetitverlust, Suizidalität

43.1 posttraumatische Belastungsreaktion

Symptome:
- Beginn innerhalb weniger Wochen bis 6 Monate nach einem Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß
- anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben
- sich aufdrängende Erinnerungen (Intrusionen)
- Nachhallerinnerungen, Flashbacks
- Albträume
- innere Bedrängnis in Situationen, die der belastenden ähneln + Vermeidungsverhalten
- sozialer Rückzug
  - Suizidgefahr
  - Angst und depressive Verstimmungen

- **Symptome der Übererregtheit (Hyperarousal)**

a) Schlafprobleme
b) Reizbarkeit und Wutausbrüche
c) Konzentrationsprobleme
d) Hypervigilanz
e) erhöhte Schreckhaftigkeit

Merke für die Praxis:
Ob und wie stark ein Ereignis traumatisierend verarbeitet wird oder nicht, hängt ab
... von Länge, Ausmaß und Wiederholung des Ereignisses
... vom Grad der Überforderung der jetzigen, momentanen Verarbeitungsmöglichkeit des Gehirns während des Ereignisses
... vom Ausmaß des erlebten Stresses und der nachfolgenden „Freeze"-Reaktion
... vom erlebten Grad der inneren Überwältigung
... vom erlebten Ausmaß der eigenen Unfähigkeit und Hilflosigkeit
... vom unterstützenden / oder fehlenden sozialen Umfeld
... von der eigenen (Trauma)-Vorgeschichte und psychischen Stabilität

Traumatherapie

Ein traumatherapeutischer Gesamtbehandlungsplan orientiert sich nach Expertenmeinung am 3-Phasenmodell der Traumatherapie:

- **Stabilisierung**
- **Traumabearbeitung**
- **Psychosoziale Reintegration**

Wozu braucht es Stabilisierung?
- um dem quälenden Erleben von Ohnmacht, Ausgeliefertsein und
- Hilflosigkeit zu begegnen
- um wieder die Kontrolle über sich und seine emotionalen Reaktionen zu gewinnen
- um aktive Möglichkeiten zur Selbstregulation und Selbstberuhigung zu finden

Was bedeutet Stabilisierung?:

- Vertrauensvolles tragfähiges Arbeitsbündnis, Vertrauensaufbau (eine aktive und zugewandte Grundhaltung ist essenziell)
- Hilfe beim Wiedererlangen selbstregulativer Funktionen
- das Wiedererlangen der Kontrolle über das eigene Erleben zu stärken.
- Hilfe bei der Differenzierung und Regulierung von Affekten
- Aufbauen und Aktivieren von Selbstfürsorge
- Wiederfinden einer Lebensperspektive
- Selbstwirksamkeitserfahrungen, Selbstwirksamkeitsstärkung
- Herstellen äußerer und innerer Sicherheit
- Klärung und Regelung finanzieller und beruflicher Probleme
- Förderung von Autonomie und Selbstkontrolle
- Unterstützung eines psychosozialen Helfersystems
- Förderung sozialer Bindung, Aufbau und Aktivierung sozialer Kontakte.
- Vermeidung von Stressfaktoren
- Ressourcenorientierung, Analyse und Aufbau psychosozialer Ressourcen
- Aktivierung von kreativen Fähigkeiten und Interessen
- Erlernen von Selbstberuhigungstechniken
- Techniken zur Distanzierung von belastenden Erinnerungsinhalten, z.B. Imaginationsübungen (sicherer Ort), um sich nicht mehr ausgeliefert fühlen zu müssen und inneren Trost zu finden
- Stressreduktion
- Notfallkoffer

Wichtig! Traumabearbeitung NUR nach ausreichender Stabilisierung!

Psychohygiene

Belastungsfaktoren für Therapeuten

(angelehnt an Rehan-Sommer & Kämmerer, 2019):

1. **Die therapeutische Beziehung**: Wir sind täglich mit den Problemen und dem Leid anderer beschäftigt. Unsere Aufmerksamkeit und auch unsere emotionalen und kognitiven Kapazitäten sind oft bei anderen. Das kann dazu führen, dass wir den Kontakt zu uns verlieren.
2. **Klient:innen**: Schwierige/belastende Themen, keine Motivation, schwieriges Interaktionsverhalten etc.
3. **Arbeitsbedingungen:** Hoher Druck, Zeitknappheit, Teamdynamik, Personalmangel, hoher und ständig wechselnder Bürokratieaufwand etc. Zudem wird im Gesundheitssystem Überbelastung häufig normalisiert, was dazu verleitet, die Fehler bei sich selbst zu suchen.
4. **Belastungen und Probleme aus dem Privatleben**: Wir sind auch Menschen mit eigenen Themen und Vulnerabilitäten. Zudem leben wir in einer Welt, in der sich die allgewärtigen Belastungsfaktoren erhöht haben: Nachwirkungen der Pandemie, politische Konflikte, Klimawandel, Beschleunigung in allen Lebensbereichen, Rollenkonflikte etc. Auch dafür sollten noch Zeit und Kapazitäten zur Verfügung stehen.
5. **Persönliche Eigenschaften und Merkmale:** Überhöhte Ansprüche, Hang zur Selbstaufopferung, Perfektionismus, hohe Empathiefähigkeit, Leistungsfähigkeit.

6. **Beschleunigung:** Immer neue Therapiemethoden und differenziertere Diagnoseverfahren können Selbstzweifel, Druck und Versagensängste auslösen.
7. **Scham:** als Helfer:in selbst Hilfe zu brauchen. Dies führt dann dazu, Warnzeichen nicht ernst zu nehmen.

Entnommen am 10.04.2025 aus: https://psylife.de/magazin/lets-talk-about-therapeutinnengesundheit-ein-erfuellender-beruf-mit- risiken

Balanceakt zwischen Mitgefühl und Neutralität

Empathie = „einfühlendes Verstehen",

- es beinhaltet die Fähigkeit, die Perspektive und Erfahrungswelt anderer wahrnehmen zu können (vgl. Stangl, 2024).
- Dazu gehört das Erkennen, Verstehen und Nachempfinden der Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person

- Wenn Mitgefühl zu Mitleid wird, können wir nicht mehr unterscheiden zwischen eigenen Emotionen und denen der Klient:innen.
- Mitgefühl kann allerdings auch zur Annahme verleiten, die persönliche Wahrnehmung der Situation eines anderen sei identisch sei zu der eigenen Wahrnehmung => das kann im therapeutischen Kontext ebenfalls zu Fehlinterpretationen und -interventionen führen
- Mitgefühl könnte zu übergriffigen Aktionen verleiten, wenn wir bewusst oder unbewusst dazu eingeladen werden, Klient:innen zu retten.
- Wenn Eigenverantwortung und der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit im Klientensystem fehlen, dann ist die Einladung sehr groß, in die Retterrolle zu gehen - hier hilft es, sich immer wieder an die eigene Rolle als Psychotherapeut:in zu erinnern

- **Neutralität**: Wie weit ist nah genug?

„Ich weiß, dass ich nichts weiß" Sokrates.

- wir kennen nicht die Wahrheit in Bezug auf ein Klientensystem
- wir können nur Ideen anbieten, aber der/die Klient:in entscheidet, was zu ihr oder ihm passt
- Neutralität fördert selbständiges Wachstum
- Neutralität ermöglicht, vorurteilsfreien Raum zu wahren, dadurch öffnen sich Klient:innen, sprechen über ihre Gedanken und Gefühle, ohne Angst vor schneller Bewertung.
- Neutralität befähigt, Gedanken und Gefühle im Klientensystem zu erkunden, ohne sie mit eigenen Überzeugungen zu vermischen
- Dadurch wahren wir einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe.
- Abhängigkeiten oder gar Manipulationen können so verhindert werden.

- **Balance zwischen Mitgefühl und Neutralität gelingt, wenn wir selbst in Balance sind**
- eigene Selbstfürsorge, Psychohygiene und Balance in Berufs- und Privatleben sind die Voraussetzung dafür

Werkzeug: Der Bilderrahmen

Ich möchte dir ein zweites, kreatives Werkzeug anbieten, mit Hilfe dessen du deine Neutralität gegenüber eines oder mehrerer Klientensysteme reflektieren kannst.Stell dir vor, deine Praxis sei eine Bildergalerie, in der beispielhaft ein Klientensystem in einem Bilderrahmen abgebildet ist. Der Bilderrahmen könnte eine ganze Wand füllen oder so groß sein wie deine Handfläche. Versuche alle Informationen aus dem Klientensystem in den Bilderrahmen zu füllen, egal ob abstrakt oder realistisch, und stelle dir dazu zum Beispiel folgende Fragen:

- *Wie voll oder wie leer ist der Bilderrahmen?*
- *Wirkt der Inhalt konfus oder geordnet, hell oder dunkel, bunt oder schwarz-weiß?*
- *Wie attraktiv ist das entstandene Bild für mich?*
- *Gibt es Bereiche, die mich besonders in eine Nähe oder Distanz bringen und weshalb?*
- *Wie nah oder weit stehe ich von dem Bilderrahmen entfernt?*
- *Was ist eine angenehme, angemessene Distanz zu dem Bild und muss ich etwas an meiner Position verändern?*
- *Was könnte mir helfen, dieses innere Bild am Ende einer Sitzung dem/der Klient:in mitzugeben?*

Tipp: Du kannst dir am Ende einer Sitzung vorstellen, wie du neue Informationen in den Rahmen hineinfließen lässt. Alle „Bilderrahmen" lässt du in deiner Praxis, es wird nichts mit nach Hause genommen. Achte auch darauf, dass du am Ende eines Therapieprozesses den Bilderrahmen innerlich den Klient:innen mitgibst. Die Bilderrahmen sollen nicht irgendwo in deinem inneren Therapieraum „zurückbleiben".

Entnommen am 09.04.2025 aus: https://psylife.de/magazin/zwischen-empathie-und-neutralitaet-so-gelingt-der-balanceakt

Impulsfragen zum Thema Psychohygiene

- Mit wieviel Klienten / Klientengruppen kann möchte ich am Tag arbeiten?
- Kann ich Klienten auch ablehnen?
- Wieviel Zeit brauche ich zwischen den Terminen, um gut bei mir anzukommen und mich vollumfänglich dem nächsten Klienten zu widmen?
- Mit welchen Klienten arbeite ich gern? Möchte ich lieber mit einzelnen Klienten arbeiten, oder mit Gruppen?
- Sind meine Räumlichkeiten (Praxis, Atelier) so eingerichtet und gestaltet, dass ich mich darin wohlfühle?
- Wie gelingt mir die Balance zwischen Mitgefühl und Neutralität ?
- Wie ist mein Zeitmanagement?
- Hast du die fünf Säulen der Work-Life-Balance im Blick? (Arbeit, Leistung, Zeitstruktur / Partnerschaft, Familie / Körper, Gesundheit, Gefühle/ Freunde, gesellschaftliches Engagement

Selbstfürsorge: „Ich verstehe darunter einen liebevollen,wertschätzenden, achtsamen und mitfühlenden Umgang mit mir selbst und das Ernstnehmen meiner Bedürfnisse." - Luise Reddemann (2005, S. 565)

Wie steht es um deine Selbstfürsorge?

- Hast du genügend Schlaf?
- Habe ich Zeitinseln nur für mich? Regelmäßige kleine Pausen und Auszeiten, egal wie kurz oder lang, helfen dir, um wieder in Kontakt mit dir und deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu treten.
- Strukturen - Schaffe dir für dich passende und angenehme Strukturen. Lasse genügend Zeit zwischen Terminen. Plane feste Pausen ein. Wann sind gute Zeiträume für Gespräche, wann für Organisation und Doku?
- Setze Grenzen! Du darfst Patient:innen ablehnen, wenn sie nicht zu dir passen oder du schon
- eine ausreichende Anzahl hast.
- Kenne deine vulnerablen Punkte und pass gut auf dich auf!
- Reflektiere! - dein eigenes Befinden, deine Energie, und deine Lebenssituation - kannst du deine Werte leben und deine Rollen so gestalten, wie sie zu dir passen
- Reflektiere in Bezug auf Klienten:innengespräche, was gut gelaufen ist, was dir Spaß macht und was du noch lernen möchtest
- Mach Check-ins! Sie helfen dir, dich um deine eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu kümmern. Nimm dir bewusst Zeit um in dich hineinzuhören. So kannst du zum Beispiel vor einer Sitzung eine bequeme Sitzhaltung einnehmen. Dann atme bewusst dreimal tief ein und aus und mache ein Check-in in deinen Körper.
- Entwickle Rituale um den Praxisalltag, Atelieralltag zu beginnen und auch wieder zu beenden!
- Manchmal brauchen wir selbst Hilfe von außen - Intervisionsgruppe, Supervision, Selbsterfahrung, Coaching oder eine Therapie sein. Scheu dich nicht, dir diese Hilfe zu suchen.
- Entwickle Selbstmitgefühl!

Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama sagte dazu:
„Damit jemand echtes Mitgefühl für andere entwickeln kann, muss er zuerst ein Fundament haben, auf dem er Mitgefühl kultivieren kann. Dieses Fundament ist die Fähigkeit, sich mit den eigenen Gefühlen zu verbinden und sich um sein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Fürsorge für andere bedarf der Fürsorge für sich selbst."